

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ

- Ερευνώνται οι συνθήκες και ο μηχανισμός πρόκλησης του κατάγματος (που; πότε; πως;). Αξιολόγηση παραμόρφωσης, κινητικότητας / αισθητικότητας. Ανώμαλος ήχος (*crepitus*). Έλεγχος αν αφορά σε απλό κάταγμα ή επιπλεγμένο ή/και για άλλες συνοδές κακώσεις.
- Λεπτομερής λήψη ιστορικού για συνύπαρξη ή υποψία άλλων συστηματικών νοσημάτων (Οστεοπόρωση, συμπαγές νεόπλασμα, πολλαπλό μυέλωμα, λεμφώματα, ΣΔ, νόσος Crohn, ΧΝΑ, κ.ά.) ή λήψη φαρμάκων (κορτικοστεροειδή, αντιπηκτικά, χημειοθεραπευτικά, κ.ά.).
- Παρά την ευρέως επικρατούσα άποψη, οι κακώσεις των άκρων πιθανώς να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις ολιγαιμίας, έως και σε σοβαρή ολιγαιμική καταπληξία, ειδικά σε ηλικιωμένους και σε επιπλεγμένα κατάγματα. Αναλόγως δε, της έντασης της βίας που τα προκάλεσε και της ποιότητας του κατεαγέντος οστού, τα κατάγματα διακρίνονται σε:
 - **Βία:** Είναι τα κατάγματα που προκαλούνται από άσκηση ισχυρής βίας, που δρα μια φορά και στιγμιαία επί φυσιολογικού οστού. Αφορά δε, στα συνήθη κατάγματα.
 - **Από καταπόνηση:** Ονομάζονται αυτά που προκαλούνται από μικρής έντασης βία, που δρα πολλές φορές πάνω σε φυσιολογικό οστό και η οποία εάν δρούσε μία φορά, δεν θα προκαλούσε το κάταγμα. Η συχνότητα εμφάνισης των καταγμάτων εκ καταπόνησης (ή κόπωσης) κυμαίνεται μεταξύ 5% - 30% ανάλογα με τη δραστηριότητα, αλλά και την παρουσία παραγόντων κινδύνου. Συνήθεις θέσεις εμφάνισης καταγμάτων κόπωσης σε αθλητές, είναι: η σπονδυλική στήλη (σπονδυλόλυση), η άνω και η κάτω επιφάνεια του αυχένα του μηριαίου οστού στο ισχίο, ο κάτω κλάδος του ηβικού οστού στην πύελο, η κνήμη, η περόνη, η πτέρνα, το σκαφοειδές και τα οστά του τάρσου και μεταταρσίου.
 - **Παθολογικά:** Είναι εκείνα που προκαλούνται από ασήμαντη βία, η οποία δρα σε οστό που παρουσιάζει κάποια νοσολογία (π.χ. οστεοπόρωση, κύστη, όγκος, οστεομυελίτιδα, νόσος Paget, κ.ά.). Επισυμβαίνουν σε οστική περιοχή η αντοχή της οποίας έχει μειωθεί και η οστική αρχιτεκτονική έχει διαταραχθεί λόγω της υποκείμενης νόσου.
- Αναλόγως κλινικής εικόνας ή απεικονιζόμενης βλάβης, τα κατάγματα διακρίνονται σε:
 - **Ανοικτά (επιπλεγμένα):** Ονομάζονται τα κατάγματα που συνοδεύονται από τραύμα μέσα από το οποίο τα κατεαγέντα οστά επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία, τα κατάγματα λέγονται «κλειστά». Ακριβέστερα, ο όρος «επιπλεγμένο» υποδηλώνει ένα κάταγμα το οποίο συνοδεύεται από επιπλοκές (π.χ. ρήξη αγγείων ή νεύρων) και το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι ανοικτό.
 - **Ενσφηνωμένα κατάγματα:** Όταν το τμήμα με τη μικρότερη διάμετρο ενσφηνώνεται μέσα στο άλλο με τη μεγαλύτερη. Συνήθως, είναι σταθερά, δεν χρειάζονται ανάταξη και η πάρωση επιτυγχάνεται σχετικά γρήγορα. Συμβαίνουν συχνότερα στην περιοχή του χειρουργικού αυχένα του βραχιονίου ή του αυχένα του μηριαίου οστού και είναι συχνά πιθανόν να μη διαγνωσθούν αμέσως κλινικά, παρά μόνον απεικονιστικά, επειδή η λειτουργικότητα του πληγέντος μέλους διατηρείται παρά το σχετικά ήπιο άλγος.
 - **Αποσπαστικά:** Καλούνται τα κατάγματα εκείνα που συμβαίνουν σε σημεία πρόσφυσης των μυών, ύστερα από βίαιη σύσπασή τους (π.χ. απόσπαση της πρόσθιας κάτω λαγόνιας άκανθας από σύσπαση του ορθού μηριαίου, αποσπαστικό κάταγμα ωλεκράνου, κ.ά.).
 - **Συντριπτικά:** Ονομάζονται τα κατάγματα εκείνα τα οποία στο επίπεδο της κάκωσης (οστικής θραύσης) παρουσιάζουν περισσότερα από τρία οστικά τμήματα.
 - **Διπλά ή διπολικά:** Ονομάζονται τα κατάγματα εκείνα όπου στο ίδιο οστό υπάρχουν δύο λύσεις (θραύσεις) της οστικής συνέχειας, που απέχουν όμως μεταξύ τους.
 - **Συμπιεστικά:** Είναι τα κατάγματα τα οποία συμβαίνουν στα σπογγώδη οστά και οφείλονται σε καθίζηση των οστικών δοκίδων τους (σπόνδυλοι, επιφύσεις της κνήμης).
- Αν το κάταγμα είναι στην πηγεοκαρπική άρθρωση (π.χ. κάταγμα Colles, Smith, Burton) ελέγχουμε πρωτίστως αν μπορεί να ψηλαφηθεί ο σφυγμός της κερκιδικής αρτηρίας.
- Στην 3^η ηλικία, τα συχνότερα κατάγματα, είναι: ισχίου, καρπού και σπονδυλικής στήλης.